

Bogen B

Rheumanetzwerk-/Ärzteumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: belastbare Erhebung des heutigen Standardwegs bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis und des erwarteten Nutzens von RheumaCheck aus Sicht ärztlicher und versorgungsnaher Akteure.

Dokumenttyp	Fragebogen-Entwurf + digitale Strukturvorgaben
Zielgruppe	Mitglieder des Rheumanetzwerks, Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, Ambulanzen, Klinik-/MVZ-Akteure
Einordnung	Korrigierte V6-Struktur: Bogen B ist primär eine Umfrage zur Standardmethode unter Versorgungsakteuren, nicht nur ein Patienten-Ist-Stand-Bogen.
Status	Finalisierungsfähige Arbeitsfassung; inhaltlich mit Robert Lange, Michael Zänker und Prof. Frank Bier abzustimmen.

1. Warum dieser Bogen B jetzt neu gefasst wird

Die erneute Prüfung des vollständigen Projektordners hat die bisherige Interpretation geschärft: Die Umfrage zur Standardmethode ist im IMDB-Arbeitspaket AP8 nicht nur als patientenbezogene Ist-Stand-Erhebung zu verstehen. Sie ist ausdrücklich als Umfrage unter den Mitgliedern des Rheumanetzwerks angelegt. Deshalb wird Bogen B in V6.1 primär als Rheumanetzwerk-/Ärzteumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad aufgebaut.

- Bogen A bleibt der patientengerichtete Vorab-Anamnese- und Stratifizierungsbogen.
- Bogen B wird als ärztliche/versorgungsstrukturelle Standardmethoden-Umfrage neu aufgebaut.
- Bogen C bleibt die patientengerichtete Usability- und Nutzenbewertung nach Nutzung.
- Bogen D kann als ergänzende, stärker produkt- und implementierungsorientierte Ärzteumfrage geführt oder später mit Bogen B kombiniert werden.

2. Quellenbasis und Projektableitung

Die folgenden Originalquellen und Projektstände begründen diese Fassung:

Quelle	Relevanter Inhalt	Bedeutung für Bogen B
IMDB-Teilvorhabenbeschreibung, AP8	Studie zur Wirkung der Maßnahme auf die Versorgung von RA-Patienten; Vergleich zur Standardmethode; Erstellung Umfrage zur Standardmethode; Einsatzmittel: Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks.	Bogen B muss Versorgungsakteure befragen und den heutigen Standardprozess abbilden.

Gesamtvorhabensbeschreibung	AP7: Machbarkeitsstudie mit Patientenbefragung und Stratifizierung; AP8: Erfolgskontrolle, Vergleich RheumaCheck mit Standardmethode.	Bogen B liefert Vergleichsbasis für den Nutzen von RheumaCheck.
Zwischenbericht 2025	Recherche und Vorbereitung der Umfrage zur Standardmethode in Absprache mit IKB begonnen.	Bogen B ist ein bereits begonnenes Arbeitspaket, nicht nur eine neue Idee.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung erst in GrobAbstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.	Sequenzielle Abstimmungslogik: erst intern/Robert, danach klinisch/IKB.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; Themen bleiben weiter zu schärfen.	V6.1 dient als strukturierter Aufschlag für die nächste Abstimmung.

3. Zielsetzung von Bogen B

Bogen B soll den heutigen Standardweg bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis aus Sicht der Versorgung erfassen. Der Fragebogen soll nicht einzelne Patientendaten sammeln, sondern typische Abläufe, Zeitverzögerungen, Hürden und Entscheidungslogiken im Rheumanetzwerk sichtbar machen.

- Wie werden Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden aktuell erkannt, abgeklärt und zugewiesen?
- Welche Zeiträume entstehen bis zur Erstdiagnose und bis zur Therapieeinleitung?
- Welche diagnostischen Schritte gehören zur Standardmethode?
- Wo entstehen die größten Verzögerungen oder Informationsverluste?
- Wie könnte RheumaCheck den Versorgungspfad sinnvoll unterstützen?
- Welche Daten und Testeigenschaften wären aus ärztlicher Sicht erforderlich, damit RheumaCheck akzeptiert wird?

4. Zielgruppen und Einsatzformat

Primäre Zielgruppe sind Mitglieder des Rheumanetzwerks und ärztliche/versorgungsnahe Akteure, die Patient:innen mit Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankungen sehen, überweisen, diagnostisch begleiten oder in der Terminsteuerung beteiligt sind.

- Rheumatolog:innen und rheumatologische Ambulanzen
- Hausärzt:innen und internistische Erstversorger
- Orthopädische / internistische Fachpraxen mit Gelenkbeschwerden als häufigem Anlass
- Klinik-/MVZ-Strukturen, Versorgungskoordination, ggf. MFA/Case-Management
- Optional: Labor-/Diagnostikakteure, wenn Prozess- und Befundintegration bewertet werden soll

Empfohlenes Format: 8-12 Minuten Online-Fragebogen mit klarer Sprunglogik. Für die Diskussion kann zunächst eine Word-/PDF-Fassung genutzt werden; für die eigentliche Erhebung empfiehlt sich eine digitale Umsetzung in Microsoft Forms, LimeSurvey, REDCap oder einer späteren salveita-/RheumaCheck-Plattform.

5. Fragebogen B - Vollversion V6.1

Hinweis für die spätere digitale Fassung: Die Antwortformate sind so gewählt, dass sie direkt in ein Online-Formular übertragen werden können. Freitext wird sparsam eingesetzt und dient vor allem zur qualitativen Ergänzung.

Block 1: Rolle, Setting und Versorgungskontext

B1.1. In welcher Funktion beantworten Sie diesen Fragebogen?

Zweck: Stratifiziert die Antworten nach Versorgungsperspektive.

Antwortformat: Einzelauswahl: Rheumatolog:in; Hausärzt:in; Internist:in; Orthopäd:in; Klinikambulanz; MVZ/Praxismanagement; MFA/Versorgungskoordination; Labor/Diagnostik; Sonstiges.

Auswertung: Gruppenvergleich nach Rolle.

B1.2. In welchem Setting arbeiten Sie überwiegend?

Zweck: Erfasst, ob der Standardprozess aus Praxis-, Klinik- oder Netzwerkperspektive beschrieben wird.

Antwortformat: Einzelauswahl: Einzel-/Gemeinschaftspraxis; MVZ; Klinikambulanz; stationäre Klinik; Netzwerk-/Koordinationsstruktur; anderes Setting.

Auswertung: Settingabhängige Barrieren und Prozesswege auswerten.

B1.3. Wie häufig sehen Sie Patient:innen mit unklaren Gelenksbeschwerden oder Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung?

Zweck: Schätzt Relevanz und Erfahrung der Befragten ein.

Antwortformat: Einzelauswahl: täglich; wöchentlich; monatlich; seltener; kaum/nie.

Auswertung: Antworten nach Erfahrung gewichten.

B1.4. Wie viele Erstkontakte mit möglichem RA-Verdacht betreffen Ihre Einrichtung ungefähr pro Monat? (optional)

Zweck: Erlaubt grobe Abschätzung des potenziellen Anwendungsvolumens.

Antwortformat: Zahlenfeld oder Kategorien: 0-5; 6-20; 21-50; >50; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Markt-/Versorgungsrelevanz grob ableiten.

Block 2: Aktueller Standardweg bei RA-Verdacht

B2.1. Was ist bei Ihnen typischerweise der erste Anlass für eine RA-Abklärung?

Zweck: Erfasst, welche Symptomkonstellationen den Prozess starten.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Gelenkschmerzen; Gelenkschwellung; Morgensteifigkeit; auffällige Laborwerte; Überweisung; familiäre Belastung; unspezifische Entzündungszeichen; anderes.

Auswertung: Anknüpfung an Bogen A / Patientenanamnese.

B2.2. Welche diagnostischen Schritte gehören in Ihrer Praxis/Klinik typischerweise zur Standardmethode bei Verdacht auf RA?

Zweck: Definiert die Vergleichsbasis gegen RheumaCheck.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: klinische Untersuchung; RF; Anti-CCP; CRP; BSG; Blutbild; Sonografie; Röntgen; MRT; Überweisung Rheumatologie; Verlaufsbeobachtung; andere.

Auswertung: Standardmethode als Vergleichspfad operationalisieren.

B2.3. Welche Laborwerte sind bei Ihnen für die frühe Einordnung besonders relevant?

Zweck: Priorisiert die Marker im realen Versorgungspfad.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Anti-CCP; Rheumafaktor; CRP; BSG; ANA; HLA-B27; andere; keine klare Priorität.

Auswertung: Abgleich mit RheumaCheck-Biomarkern.

B2.4. Wie wird bei Ihnen entschieden, ob eine rheumatologische Vorstellung dringend ist?

Zweck: Erfasst Triagekriterien.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: kleine Hand-/Fußgelenke; mehrere Gelenke; Schwellung/Synovitis; Morgensteifigkeit; hohe Entzündungswerte; positive CCP/RF; Funktionsverlust; starke Schmerzen; klinischer Gesamteindruck.

Auswertung: Kann in digitale Triage-/Fragebogenlogik einfließen.

Block 3: Zeitachsen und Verzögerungen

B3.1. Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach typischerweise vom Symptombeginn bis zum ersten ärztlichen Kontakt?

Zweck: Erfasst Patientenverzögerung im Standardweg.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Vergleich zu Projektziel: frühere Einordnung.

B3.2. Wie lange dauert es typischerweise vom ersten ärztlichen Kontakt bis zur rheumatologischen Vorstellung?

Zweck: Erfasst Zuweisungs-/Wartezeit.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend; nicht zutreffend.

Auswertung: Kernvariable für Versorgungseffekt.

B3.3. Wie lange dauert es typischerweise bis zur gesicherten Diagnose oder belastbaren Arbeitsdiagnose?

Zweck: Erfasst diagnostischen Delay.

Antwortformat: Kategorien: <4 Wochen; 1-3 Monate; 3-6 Monate; >6 Monate; stark variierend; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Vergleich Standardmethode vs. RheumaCheck.

B3.4. Wie lange dauert es typischerweise bis zur Therapieeinleitung, wenn sich ein RA-Verdacht bestätigt?

Zweck: Erfasst Therapie-Delay.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen nach Diagnose; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend.

Auswertung: AP8 nennt Zeit zur Therapieeinleitung als Beispielparameter.

B3.5. Wo entstehen aus Ihrer Sicht die größten Verzögerungen?

Zweck: Identifiziert Engpässe.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Patient:innen warten zu lange; unspezifische Symptome; fehlende Laborwerte; Wartezeit Rheumatologie; Überweisungsprozess; fehlende digitale Vorinformationen; unklare Priorisierung; Terminlogistik; anderes.

Auswertung: Top-Barrieren für Begleitforschung und Implementierung.

Block 4: Bewertung der heutigen Standardmethode

B4.1. Wie gut funktioniert der heutige Standardweg zur frühen RA-Abklärung insgesamt?

Zweck: Quantifiziert Ausgangsbewertung.

Antwortformat: Skala 1-5: sehr schlecht bis sehr gut.

Auswertung: Baseline der Standardmethode.

B4.2. Wie gut gelingt es aktuell, Patient:innen mit hohem RA-Risiko frühzeitig zu priorisieren?

Zweck: Bewertet Triagequalität.

Antwortformat: Skala 1-5: gar nicht gut bis sehr gut.

Auswertung: Niedrige Werte begründen Bedarf an RheumaCheck.

B4.3. Wie zufrieden sind Sie mit der Verfügbarkeit und Geschwindigkeit relevanter Laborinformationen?

Zweck: Bewertet diagnostische Infrastruktur.

Antwortformat: Skala 1-5 plus Option: nicht beurteilbar.

Auswertung: Abgleich mit Point-of-Need-Testnutzen.

B4.4. Welche Informationen fehlen Ihnen bei Überweisungen oder Erstvorstellungen am häufigsten?

Zweck: Erfasst Datenlücken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Symptombdauer; Gelenkverteilung; Schwellung/Synovitis; Morgensteifigkeit; Vorlabor; Medikationsstatus; Funktionsbeeinträchtigung; Dringlichkeit; keine wesentlichen Lücken.

Auswertung: Input für digitales Formular und Arztbericht.

Block 5: Erwarteter Nutzen von RheumaCheck

B5.1. In welchen Situationen wäre ein RheumaCheck-Test aus Ihrer Sicht besonders hilfreich?

Zweck: Definiert Use Cases.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Hausarzt-Triage; Vorselektion für Rheumatologie; Klinikambulanz; ländliche Versorgung; Verlaufskontrolle; Zweitmeinung/Telemedizin; Patient:innen mit unklaren frühen Beschwerden; anderes.

Auswertung: Priorisierung der Anwendungsszenarien.

B5.2. Welche Wirkung erwarten Sie am ehesten von RheumaCheck?

Zweck: Bewertet Nutzenhypothesen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: schnellere Abklärung; bessere Priorisierung; weniger unnötige Überweisungen; frühere Therapie; bessere Patientenvorbereitung; Entlastung von Rheumatolog:innen; kein wesentlicher Nutzen; unsicher.

Auswertung: Hypothesen für AP8 und spätere Evaluation.

B5.3. Wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie RheumaCheck in Ihrem Versorgungsumfeld nutzen oder empfehlen würden, wenn Testgüte und Workflow überzeugen?

Zweck: Adoptionssignal.

Antwortformat: Skala 0-10: sehr unwahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich.

Auswertung: Net Promoter-/Adoptionsindikator.

B5.4. Welche Mindestanforderungen müsste RheumaCheck aus Ihrer Sicht erfüllen?

Zweck: Sammelt Akzeptanzkriterien.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: hohe Sensitivität; hohe Spezifität; quantitative Werte; klare Cut-offs; schnelle Ergebniszeit; einfache Blutentnahme; geringe Kosten; digitale Befundübertragung; CE/IVDR-konform; Schulungsarme Anwendung; andere.

Auswertung: Produktanforderungen für Robert/IMDB/ASKA.

Block 6: Digitale Integration und Datenlogik

B6.1. Welche Informationen sollten zusammen mit dem Testergebnis digital übermittelt werden?

Zweck: Definiert digitales Mindestdatenset.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Symptombdauer; Gelenkbeteiligung; Schmerz; Morgensteifigkeit; Schwellung; Funktionsbeeinträchtigung; RF/CCP/CRP-Werte; Vorbefunde; Dringlichkeitsstufe; freie Arzt-/Patientennotiz.

Auswertung: Schnittstelle zu Bogen A und App/Plattform.

B6.2. Wie sollte das Ergebnis dargestellt werden, damit es im Alltag hilfreich ist?

Zweck: Erfasst Befundformat.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: numerische Werte; Ampel/Triagekategorie; kurzer Befundtext; Empfehlung zur Dringlichkeit; Verlaufsgrafik; PDF-Bericht; direkte Terminempfehlung; anderes.

Auswertung: Produkt-/UI-Anforderung.

B6.3. Welche digitalen Schnittstellen wären für Sie besonders relevant?

Zweck: Erfasst Implementierungsbedarf.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Praxissoftware; KIS; Laborinformationssystem; PDF/Email; Patienten-App; Telemedizinplattform; keine digitale Schnittstelle nötig; unsicher.

Auswertung: Implementierungs- und Barrierenanalyse.

B6.4. Welche Datenschutz- oder Prozesshürden sehen Sie bei einem digitalen RheumaCheck-Workflow?

Zweck: Erfasst Umsetzungsrisiken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Einwilligung; Datensicherheit; unklare Zuständigkeit; Dokumentationsaufwand; Integration in bestehende IT; Haftungsfragen; Schulungsbedarf; keine besonderen Hürden; anderes.

Auswertung: Frühwarnsystem für Implementierung.

Block 7: Evidenz, Pilotierung und Kooperation**B7.1. Welche Evidenz wäre für Sie notwendig, bevor Sie RheumaCheck aktiv einsetzen würden?**

Zweck: Erfasst Evidenzanforderungen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: prospektive klinische Studie; Vergleich mit Laborstandard; Real-World-Daten; gesundheitsökonomische Analyse; Nutzerstudie; ärztliche Leitlinien-/Fachgesellschaftsempfehlung; CE/IVDR-Nachweis; anderes.

Auswertung: Planung Validierung und Kommunikation.

B7.2. Wären Sie grundsätzlich bereit, an einer Pilotierung oder Versorgungsstudie mitzuwirken?

Zweck: Identifiziert Kooperationspotenzial.

Antwortformat: Einzelauswahl: ja; eher ja; eher nein; nein; abhängig von Aufwand/Vergütung/Datenschutz.

Auswertung: Rekrutierung Netzwerkpartner.

B7.3. Welche Form der Beteiligung wäre realistisch?

Zweck: Konkretisiert Beteiligung.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Fragebogen beantworten; Patient:innen informieren; Test in Praxis/Klinik einsetzen; anonymisierte Prozessdaten liefern; Feedbackgespräch; Teilnahme an Workshop; keine Beteiligung möglich.

Auswertung: Nächste Schritte für Rheumanetzwerk.

B7.4. Welche offenen Hinweise oder Bedenken möchten Sie ergänzen? (optional)

Zweck: Qualitative Rückmeldung.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Offene Themen für Projektteam.

6. Kurzversion für schnelle Netzwerkabfrage

Falls eine erste schnelle Abfrage im Rheumanetzwerk erfolgen soll, kann eine Kurzversion mit 10 Kernfragen genutzt werden. Sie sollte maximal 5 Minuten dauern und die spätere Vollversion vorbereiten.

- Rolle / Fachgebiet / Setting
- Häufigkeit unklarer Gelenksbeschwerden oder RA-Verdacht
- typische Standarddiagnostik bei RA-Verdacht
- typische Zeit bis rheumatologische Vorstellung
- typische Zeit bis Diagnose / Therapieeinleitung
- größte Verzögerungspunkte im aktuellen Ablauf
- erwarteter Nutzen von RheumaCheck
- Mindestanforderungen an Testgüte und Workflow
- notwendige digitale Ergebnisdarstellung
- Bereitschaft zur Pilotierung / Mitwirkung

7. Digitale Umsetzung und Sprunglogik

Für die spätere Online-Erhebung sollte Bogen B modular umgesetzt werden. Nicht jede Zielgruppe muss alle Detailfragen sehen. Empfohlen wird eine einfache Sprunglogik:

- Hausärzt:innen: Fokus auf Erstkontakt, Überweisung, frühe Labor-/Triage-Entscheidungen.
- Rheumatolog:innen: Fokus auf Priorisierung, Vorbefunde, Qualität der Zuweisung und Diagnosesicherung.
- Klinik/MVZ/Ambulanz: Fokus auf Prozessintegration, Terminsteuerung, digitale Befunde.
- Labor/Diagnostik: Fokus auf Testgüte, Befundformat, Schnittstellen und Qualitätssicherung.
- Wenn keine direkten RA-Verdachtsfälle gesehen werden: Kurzroute zu Einschätzung des Netzwerk- und Implementierungsnutzens.

8. Auswertungsplan

Die Auswertung sollte nicht nur deskriptiv erfolgen, sondern direkt auf die AP8-Zielsetzung einzahlen: Vergleich des RheumaCheck-Ansatzes mit der Standardmethode und Abschätzung des Versorgungseffekts.

Dimension	Mögliche Kennzahl	Nutzung im Projekt
Versorgungsdauer	median/typisch geschätzte Zeit bis Facharzt, Diagnose, Therapie	Baseline für Standardmethode
Engpässe	Top-3-Barrieren nach Häufigkeit	Ableitung Implementierungsstrategie
Erwarteter Nutzen	Likert-/0-10-Bewertung	Priorisierung Produktversprechen
Akzeptanz	Nutzungs-/Empfehlungswahrscheinlichkeit	Go-to-market-/Pilotpotenzial
Digitale Integration	gewünschte Schnittstellen / Befundformate	Anforderung an salvevita-Plattform
Evidenzanforderung	benötigte Studien-/Validierungsnachweise	Planung klinische Validierung und Kommunikation

9. Abstimmungspunkte

Vor einer externen Ausspielung sollte Bogen B in zwei Schritten abgestimmt werden:

- Schritt 1 - IMDB / Robert Lange / salvevita: Welche Antworten werden für Plattform, Workflow, Business Case und spätere Digitalisierung gebraucht?
- Schritt 2 - IMDB / Michael Zänker / IKB: Welche Fragen sind klinisch präzise, zumutbar und für das Rheumanetzwerk realistisch?
- Schritt 3 - Prof. Frank Bier / IMDB: Welche Punkte sollen methodisch/statistisch vorab festgelegt werden, damit AP8 belastbar ausgewertet werden kann?

10. Masterprompt für die nächste Iteration

Erstelle auf Basis des RheumaCheck-Projektantrags einen digitalen, auswertbaren Fragebogen für Mitglieder des Rheumanetzwerks und ärztliche/versorgungsnahe Akteure. Ziel ist die Erhebung der heutigen Standardmethode bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis, der Zeit bis Erstdiagnose und Therapieeinleitung, der aktuellen Engpässe sowie der erwarteten Einsatzmöglichkeiten von RheumaCheck. Der Bogen soll zwischen Hausarzt-, Rheumatologie-, Klinik-/MVZ- und Laborperspektive unterscheiden, in 8-12 Minuten beantwortbar sein, überwiegend geschlossene Antwortformate nutzen und direkt in Microsoft Forms/REDCap/LimeSurvey oder eine spätere RheumaCheck-Plattform übertragbar sein. Er soll keine individuellen Patientendaten erheben, sondern typische Prozesse, Einschätzungen und Implementierungsanforderungen. Trenne Pflichtfragen, optionale Vertiefungen, Auswertungsvariablen und offene Abstimmungspunkte für Robert Lange, Michael Zänker und Prof. Frank Bier.

11. Referenz- und Orientierungspunkte

- RheumaCheck IMDB-Teilvorhabenbeschreibung: AP8 - Studie zur Wirkung der Maßnahme, Umfrage zur Standardmethode, Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks.
- RheumaCheck Gesamtvorhabensbeschreibung: AP7 Patientenbefragung und Stratifizierung; AP8 Erfolgskontrolle und Vergleich mit Standardmethode.
- RheumaCheck Zwischenbericht 2025: Recherche und Vorbereitung der Umfrage zur Standardmethode in Absprache mit IKB.
- RheumaCheck Jour fixe 09.04.2026: Fragebögen/Begleitforschung erst in Grobabstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.
- RheumaCheck Jour fixe 07.05.2026: erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; weitere Schärfung erforderlich.
- NICE RA guidance: dringliche fachärztliche Abklärung bei persistierender Synovitis, besonders bei kleinen Hand-/Fußgelenken, Mehrgelenkbeteiligung oder Verzögerung von ≥ 3 Monaten.
- EULAR early arthritis recommendations: frühzeitige Identifikation und rheumatologische Abklärung von Patient:innen mit früher Arthritis.
- SUS / AHRQ: System Usability Scale als etablierter 10-Item-Standard für spätere Usability-Erhebung in Bogen C.